Mapa de empatia

Diseñado para:
Médicos vinculados

Diseñado por
Mendoza Castañeda Sebastián
Riquelme Cuéllar Laura Sofía

Fecha :
10 de Octubre de 2026

Version:

META

1 ¿Con quién estamos empatizando?

PMédicos vinculados a la aseguradora
Atienden a pacientes asegurados que llegan a consulta, muchos de ellos sin un historial clínico completo, estudios previos y sin conocimiento de la cobertura de su póliza
Diagnostican, prescriben tratamiento médico, indican estudios, registran la atención al paciente

2 ¿Qué necesitan hacer?

Atienden al paciente correctamente de manera oportuna
Ya no tienen que atender al paciente sin conocer el historial médico del paciente
Consultan antecedentes clínicos, diagnostican, recetan medicamentos, indican la realización de estudios auxiliares, realizan procedimientos, registran la información
Deciden un diagnóstico, el tratamiento, estudios sin repetición con respecto a los anteriores, practicar un procedimiento que entre en la cobertura del asegurado, y registran la atención
Tienen consultas más rápidas y seguras, sin estudios duplicados o no apegados al diagnóstico apegados a la cobertura del paciente

3 ¿Qué ven?

Pacientes que llegan a consulta sin estudios ni su historial médico
Estudios previos en papel, CDs, fotos o formato PDF.
Pacientes con desconocimiento de la cobertura de su póliza
Agendas saturadas con poco tiempo por consulta

4 ¿Qué dicen?

¿Qué estudios le han hecho anteriormente?, ¿Los tiene a la mano?
¿Toma algún medicamento actualmente?
Tendremos que repetir o realizar el estudio indicado
Verifique con su aseguradora si está cubierto

5 ¿Qué hacen?

Le realizan preguntas al paciente para reconstruir su historial médico
Revisan los estudios que trae el paciente en distintos formatos
Solicitan estudios nuevos cuando no tienen los previos
Registran la consulta en su propio expediente

6 ¿Qué escuchan?

Pacientes que no recuerdan su diagnóstico o medicamentos
Pacientes molestos por tener que repetir el estudio o tener que pagarlo por su cuenta
Avisos sobre la confidencialidad del expediente clínico
Aseguradoras que piden información adicional o aclaraciones

7 ¿Que piensan y sienten?

Dolencias

- Historial clínico disperso entre varios especialistas
- Estudios repetidos por falta de acceso a los previos
- Incertidumbre sobre la cobertura del paciente
- Riesgo de errores por información incompleta

Ganancias

- Conocer el historial completo del paciente antes de atenderlo
- Evitar estudios duplicados y gastos innecesarios para el paciente
- Saber de inmediato qué cubre la póliza del paciente
- Tomar decisiones clínicas con mayor certeza.

- Frustración al pedir estudios que el paciente ya se hizo
- Inseguridad al diagnosticar sin el historial completo
- Preocupación por omitir alergias o interacciones de medicamentos
- Preocupación por la confidencialidad de la información clínica